ORIGEM DO DOCUMENTO:	UTI ADULTO		
TÍTULO:			Nº DOC:
MANEJO DE SEPSE E CHOQUE SÉPTICO			PRT. UTIADU.001
DATA 1º VERSÃO	**DATA DESTA VERSÃO**	**VERSÃO Nº**	**PRÓXIMA REVISÃO**
30/12/2025	30/12/2025	001	30/12/2027

1. OBJETIVO

1.1. Estabelecer diretrizes padronizadas para o reconhecimento precoce, diagnóstico e tratamento da **sepse e choque séptico** no âmbito hospitalar, visando reduzir mortalidade, otimizar recursos e garantir a qualidade assistencial.

2. ABRANGÊNCIA

2.1. Este protocolo aplica-se a **todos os pacientes internados no FCECON**, em especial nos setores de **Pronto Atendimento, Enfermarias e UTI**, envolvendo médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos e demais profissionais de saúde.

3. DEFINIÇÕES

3.1 Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica (SIRS):

Presença de ao menos dois dos seguintes critérios clínicos:

- Temperatura corporal > 38 °C (febre) ou < 36 °C (hipotermia)
- Frequência respiratória > 20 incursões respiratórias/minuto (taquipnéia) ou uma pressão parcial de CO2 no sangue arterial < 32 mmHg.
- Frequência cardíaca > 90 batimentos cardíacos/minuto.
- Aumento ou redução significativa do número de leucócitos (>12.000 ou <4.000 células/mm3), ou presença de mais 10% leucócitos jovens (bastões).

3.2 Disfunção orgânica: As disfunções orgânicas são:

- Hipotensão (PAS < 90 mmHg ou PAM < 65 mmHg ou queda de PA > 40 mmHg)
- Oligúria (≤0,5mL/Kg/h) ou elevação da creatinina acima do basal (>2mg/dL);
- Relação PaO2/FiO2 < 300 ou necessidade de O2 para manter SpO2 > 90%;
- Contagem de plaquetas < 100.000/mm³ ou redução de 50% no número de plaquetas em relação ao maior valor registrado nos últimos 3 dias;
- Acidose metabólica inexplicável: déficit de bases ≤ 5,0mEq/L e lactato acima do valor de referência;
- Rebaixamento do nível de consciência, agitação, delirium;
- Aumento significativo de bilirrubinas (>2X o valor de referência).

3.1. Sepse: Disfunção orgânica com risco de vida causada por uma resposta desregulada do hospedeiro à infecção.

3.2 Choque séptico: Sepse caracterizada por hipotensão persistente que requer o uso de vasopressores para manter a PAM ≥ 65 mmHg e por apresentarem nível de lactato sérico > 2 mmol/L (18 mg/dl), apesar da reposição volêmica adequada.

Observação: A ausência dos critérios de SIRS não exclui o diagnóstico de sepse. Alguns pacientes, principalmente idosos e imunossuprimidos e em uso de betabloqueadores, não apresentam esses sinais. Assim, na presença de uma das disfunções orgânicas, sem outra explicação plausível, pense em sepse e inicie as medidas preconizadas nos pacotes.

Caso seja comprovado posteriormente não se tratar de sepse, sempre poderemos suspender a antibioticoterapia.

4. PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS E RESPONSÁVEIS

4.1. **Médico assistente:** suspeitar, acionar protocolo, iniciar antibioticoterapia e medidas de suporte.

4.2 **Equipe de enfermagem:** aplicar triagem, monitorizar sinais vitais, coletar exames e administrar terapêutica prescrita.

4.3 **UTI:** assumir o manejo avançado de casos graves ou refratários.

4.4 **Farmácia clínica:** apoiar escolha, ajuste e descalonamento antimicrobiano.

4.5 **CCIH:** monitorar uso de antimicrobianos e indicadores de sepse.

5. DESCRIÇÃO DA ROTINA E PROCEDIMENTO

5.1 Triagem inicial (em todos os setores)

- Paciente com suspeita de infecção → aplicar **Score NEWS2**

National Early Warning Score 2 (NEWS 2) – versão brasileira

Parâmetros Fisiológicos	Pontuação						
	3	2	1	0	1	2	3
Frequência respiratória (por minuto)	≤8		9-11	12-20		21-24	≥25
Sp02 % - Escala 1	≤91	92-93	94-95	≥96			
Sp02 % - Escala 2	≤83	84-85	86-87	88-92 ≥93 em ar ambiente	93-94 com oxigênio	95-96 com oxigênio	≥97 com oxigênio
Ar ambiente ou oxigênio?		Oxigênio		Ar Ambiente			
Pressão arterial sistólica(mmHg)	≤90	91-100	101-110	111-219			≥220
Pulso (por minuto)	≤40		41-50	51-90	91-110	111-130	≥131
Consciência				Alerta			Confusão aguda Resposta a voz ou dor Irresposivo
Temperatura (°C)	≤35.0		35.1-36.0	36.1-38.0	38.1-39.0	≥39.1	

National Early Warning Score 2 (NEWS 2) ©Royal College Of Physicians 2017. Adaptação transcultural para português. Brasil, 2018.

Figura 1 – *National Early Warning Score* 2 - NEWS 2 - versão brasileira. Porto Alegre/RS, 2018
Fonte: Os autores, 2018.

- Se Score de NEWS2 maior ou igual a 5 ou um único parâmetro na coluna de 3 pontos (red score), → Após identificação do paciente com SUSPEITA de sepse, a equipe médica decide se deve ou não abrir o protocolo de SEPSE, com base nas informações disponíveis para tomada de decisão em relação à probabilidade de se tratar de sepse.

- Para adequada alocação e fluxo de pacientes com sepse na FCECON, deve-

se atentar para os critérios de gravidade, para, se necessário, realizar medidas, bem como solicitação de transferência e vaga em UTI.

- Mediante a abertura do Protocolo de Sepse, é obrigatório o preechimento dos dados no sistema SALLUX, iniciando com a aba protocolo sepse, seguido pelo pacote da 1h, pacote 6h e fechamento sepse **(Anexo 1).**

5.2. Pacote da Primeira Hora

Deve ser realizado **em até 1 hora** após o reconhecimento da SEPSE:

1. Coletar lactato sérico
2. Coletar 2 pares de hemoculturas (2 aeróbicas e 2 anaeróbicas) de sítios de punção diferentes e culturas de sítio suspeito.
3. Iniciar antibioticoterapia endovenosa apropriada de acordo ao foco suspeito.
4. Pacientes com hipotensão arterial ou hipoperfusão tecidual (lactato sérico maior ou igual a 36 mg/dl OU ≥4 mmol/L)), administrar cristaloides (30 ml/kg em até 3h).
5. Se hipotensão persistir → iniciar norepinefrina para manter PAM ≥65 mmHg.

5.3. Pacote das 6h

- Reavaliar lactato em pacientes com lactato inicial elevado (>2 mmol/L).
- Reavaliação da volemia e perfusão (após expansão volêmica inicial, reavaliar constantemente o paciente, pelo menos de 60/60 minutos, aplicando o Score de News, para definir necessidade de expansão volêmica adicional, conforme a presença de sinais de má perfusão periférica como tempo de enchimento capilar > 3 segundos, extremidades frias ou presença de livedo e/ou hipotensão arterial).
- Reavaliação da resposta hemodinâmica (PAM, diurese, perfusão, PVC, $ScvO_2$, débito urinário, pressão arterial invasiva).

- Avaliar necessidade de controle de foco infeccioso (cirurgia, drenagem, retirada de cateter).

- Considerar suporte avançado em UTI.

Observação: Nesta etapa, o responsável pela condução do caso, também deverá concluir o protocolo, definindo as confirmações, se: infecção, sepse, choque séptico ou exclusão das hipóteses anteriores.

5.4 Fechamento do protocolo da sepse

Todos os protocolos de sepse abertos, deverão ser fechados conforme desfecho, em no máximo 24 horas após a abertura do mesmo.

Em casos de transferência para UTI ou óbito o fechamento deverá ser preenchido antes que seja feita a alta administrativa.

5.5 Tratamento antimicrobiano na sepse

5.5.1 Administração de antimicrobiano empírico:

- Devem-se administrar antimicrobianos intravenosos o mais rápido possível, preferencialmente na primeira hora após o diagnóstico da sepse e antes de iniciar a terapia antimicrobiana;

- Utilizar dose máxima do antimicrobiano por Kg/peso e respeitar as características farmacocinéticas e farmacodinâmicas da droga, principalmente em relação à diluição e tempo de administração;

- Durante todo o tratamento, principalmente nas primeiras 24 horas, reavaliar seu uso conforme o resultado da coloração de Gram, das culturas e da evolução clínica.

- Em caso de insuficiência renal, ajustar a dose após 48 horas da dose cheia.

- Avaliar duração do tratamento de 7 a 10 dias para a maioria das infecções graves associadas a sepse e choque séptico e avaliar encurtamento da terapia em

pacientes com resolução clínica rápida após controle adequado de foco intra-abdominal ou sepse de foco urinário e aqueles com pielonefrite não complicada.

- As doses a seguir têm como referência um paciente de 60 kg e devem ser ajustadas de acordo com a função renal.

5.5.2 Antibioticoterapia sugerida conforme padronização institucional:

TABELA 1. Escolha terapêutica conforme o foco de infecção e infecção comunitária ou infeção hospitalar

FOCO	INFECÇÃO COMUNITARIA	INFECÇÃO HOSPITALAR
PNEUMONIA	Ampiclina/Sulbactam de 3gr de 6/6hr ou Ceftriaxona 1gr de 12/12hr + Claritromicina 500mg de 12/12hr) Antecedente de doença pulmonar obstruiva crônica – infecção moderada Levofloxacino 750 mg 1 xdia com risco para Pseudomonas aeruginosa Cefepime 2gr de 8/8hr . Se pneumonia aspirativa Ampicilina/Sulbactam 3 gr de 6/6hr ou associar Clindamicina 600mg de 8/8hr mais Ceftriaxona 1gr de 12/12hr . A utilização de Claritromicina nesse contexto não é necessária.	Ceftazidima 2gr de 8/8hr ou Cefepime 2gr de 8/8hr (Dose Anti-Pseudomonas) Se alta prevalência de estafilococos resistente a oxacilina na instituição – associar Vancomicina 25-30 mg/kg seguida de 15-20mg/kg de 12/12hr (Máximo 3gr dose). Se uso prévio de cefalosporinas ou quinolonas usar Meropenem 1 a 2gr de 8/8hr ou Imipenem 500mg de 6/6hr Se alta prevalência de germes multirresistentes (Pseudomonas multi R/ Acinetobacter multi R e Klebsiella produtora de carbapenemase) solicitar parecer da Infectologia.
URINÁRIO	Ceftriaxona 1gr de 8/8hr ou Ceftazidima 1gr de 8/8hr ou Levofloxacino 750mg 1 xdia ou Ciprofloxacino 400mg de 12/12hr	Cefepime 2 gr de 8/8hr ou Piperacilina/tazobactam 4,5gr de 6/6hr ou Meropenem 1 a 2 gr de 8/8hr ou Imipenem 500mg de 6/6hr

ABDOMINAL	Ceftriaxona 1gr de 12/12hr + Metronidazol 500mg de 8/8hr Levofloxacino 750mg 1 xdia ou Ciprofloxacino 400mg de 12/12hr + Metronidazol 500mg de 8/8hr Em caso de suspeita de Colangite Ampicilina/Sulbactam 3gr de 6/6hr	Cefepime 2gr de 8/8hr associado a Metronidazol 500mg de 8/8hr ou Piperacilina/tazobactam 4,5gr de 6/6hr. Se uso prévio de Cefepima ou Piperacilina/tazobactam usar Meropenem 1-2gr de 8/8hr ou Imipenem 500mg de 6/6hr Avaliar necessidade de cobertura adicional para Gram-positivos ou MRSA (se risco), Vancomicina IV, dose de ataque 25–30 mg/kg seguida de manutenção 15-20mg/kg de 12/12hr.
PELE / PARTES MOLES	Cefalotina 1-2gr de 6/6hr ou Oxacilina 2gr de 4/4hr ou Clindamicina 600mg de 8/8hr	Vancomicina 25–30 mg/kg seguida de manutenção 15-20mg/kg de 12/12hr ou Teicoplanina 6–12 mg/kg de 12/12hr por 2 doses seguida de 6–12 mg/kg 1xdia associado a Piperacilina/tazobactam 4,5g de 6/6hr ou Cefepime 2gr de 8/8hr ou Ceftazidima 2g de 8/8hr. Se uso prévio de Cefepima/Ceftazidima ou Piperacilina/tazobactam , usar Meropenem 1-2gr de 8/8hr ou Imipenem 500mg de 6/6hr. Na suspeita de anaeróbios acrescentar Metronidazol 500mg de 8/8hr ao esquema que contenhas cefalosporinas de 3° e 4° geração.
CORRENTE SANGUINEA ASSOCIADA A CATETER		Vancomicina 25–30 mg/kg seguida de manutenção 15-20mg/kg de 12/12hr associado a Piperacilina/tazobactam 4,5g de 6/6hr ou Cefepime 2gr de 8/8hr ou Ceftazidima 2g de 8/8hr. Vancomicina 25–30 mg/kg seguida de manutenção 15-20mg/kg de 12/12hr associado a

		Meropenem 1-2gr de 8/8hr ou Imipenem 500mg de 6/6hr. Se fatores de risco para candidemia – avaliar necessidade de cobertura para fungos com imidazólicos (Fluconazol) ou Equinocandinas (Micafungina) ou Polienos (Anfotericina B)
SNC	Adulto < 50 anos Ceftriaxona 2gr de 12/12hr Adulto ≥ 50 anos Ceftriaxona 2gr de 12/12hr associado a Ampicilina 2gr de 4/4hr. Associar Aciclovir em caso de suspeita de Encefalite viral até obter resultado de Liquor	Vancomicina 25–30 mg/kg seguida de manutenção 15-20mg/kg de 12/12hr associado a Cefepime 2gr de 8/8hr ou Ceftazidima 2g de 8/8hr. Vancomicina 25–30 mg/kg seguida de manutenção 15-20mg/kg de 12/12hr associado a Meropenem 2gr de 8/8hr ou Imipenem 500mg de 6/6hr.
SEM FOCO IDENTIFICADO	Ceftriaxona 1gr de 12/12hr	Piperacilina-tazobactam 4.5g de 6/6h

6. INDICADORES DA QUALIDADE

Indicadores de processo:

Reconhecimento e diagnóstico:

- Tempo porta–identificação da sepse
- Porcentagem de pacientes com lactato coletado na 1ª hora
- Porcentagem de pacientes com hemoculturas coletadas antes do antibiótico

Tratamento

- Tempo porta–antibiótico

- Porcentagem de pacientes que receberam antibiótico em até 1 hora
- Porcentagem de pacientes que receberam reposição volêmica adequada (30ml/kg)
- Porcentagem de pacientes com reavaliação clínica após volume

Indicadores de Resultado

- Taxa de mortalidade por sepse Geral e por unidade (PS, UTI, enfermaria)
- Tempo médio de internação
- Tempo de permanência em UTI
- Incidência de choque séptico
- Taxa de readmissão por sepse
- Redução da mortalidade após implantação do protocolo

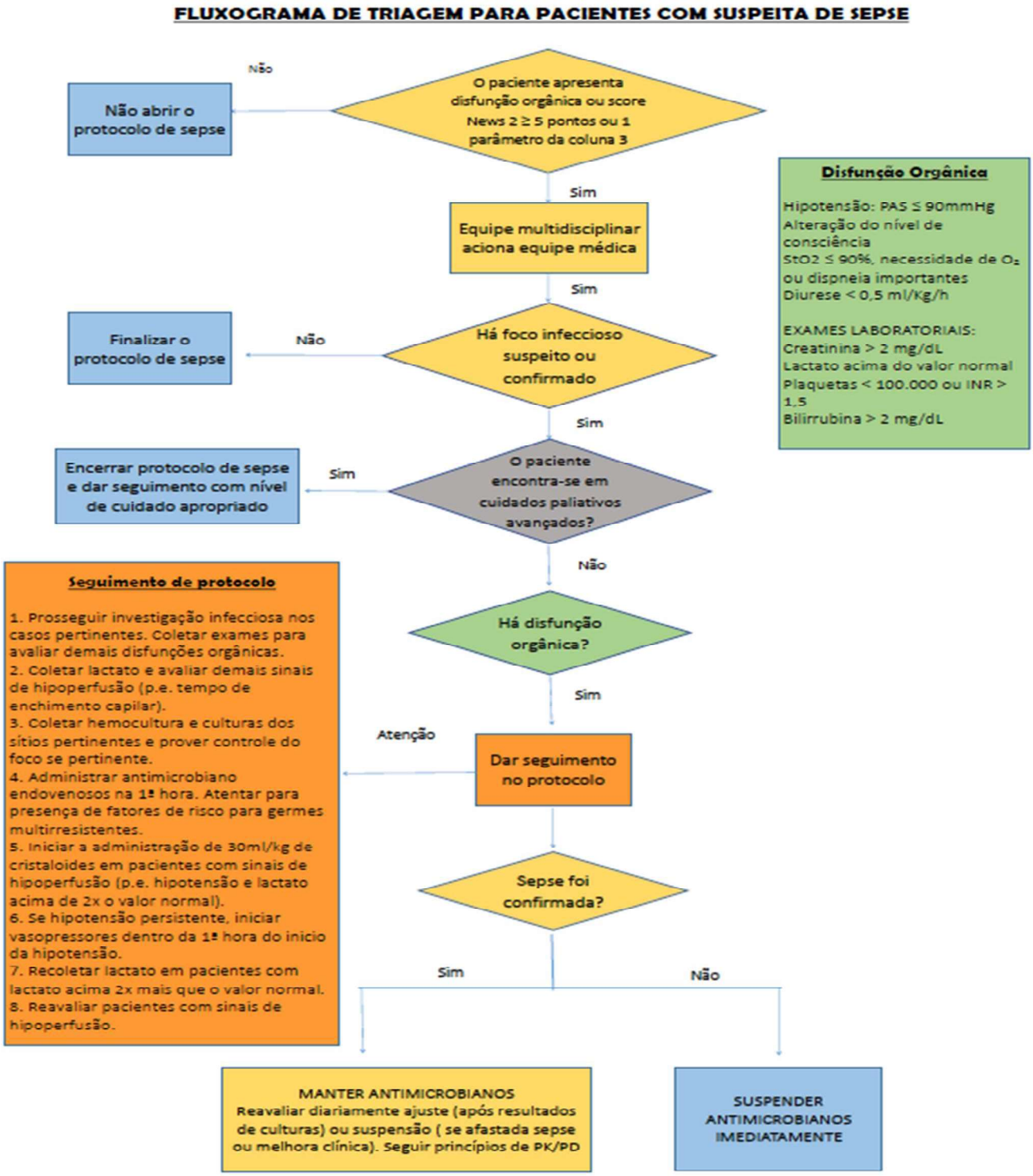
Indicadores de Adesão ao Protocolo

- Porcentagem de adesão completa ao Bundle da 1ª hora
- Porcentagem de casos de sepse tratados conforme protocolo
- Número de não conformidades identificadas em auditorias

7. ANEXOS

1. Fluxograma de reconhecimento e manejo da sepse
2. Ficha do Protocolo da Sepse e Choque séptico (esta ficha deve ser preenchida **no momento da ativação do protocolo** e acompanhada durante as primeiras 24 horas)
3. Instrumento de auditoria clinica protocolo de sepse

Anexo 1. Fluxograma de reconhecimento e manejo da sepse



Anexo 2. Ficha do Protocolo da Sepse e Choque séptico

FICHA DE PROTOCOLO DE SEPSE

Nome do paciente _____ Data de Nascimento: ___/___/___ Idade: _____

Sexo: ☐ M ☐ F Nome da mãe:_____ Prontuário: _____

Leito: _____ Diagnóstico de admissão: _____

Data e hora da abertura do protocolo de sepse: ___ /___ /____, ___: ___

Nome do profissional que ativou o protocolo de sepse:_____

Critérios de Triagem precoce	Sinais de Disfunção orgânica (marque os presentes)	Foco infeccioso
☐ Score de NEWS2 maior ou igual a 5 ☐ Score de NEWS2 com um único parâmetro na coluna de 3 pontos	☐ Hipotensão (PAM 65 mmHg ou PAS ≤ 90mmHg) ☐ Rebaixamento do nível de consciência ☐ SatO2 ≤ 90%, necessidade de O2 ou dispneia importante ☐ Oligúria (< 0,5 mL/kg/h) ☐ Creatinina > 2mg/dL ☐ Lactato ≥ 2 mmol/L ☐ Plaquetopenia < 100.000 ou INR > 1.5 ☐ Bilirrubina > 2mg/dL	☐ Pulmonar ☐ Urinário ☐ Abdominal ☐ Pele / partes moles ☐ Cateter ☐ SNC ☐ Desconhecido Outro:_____

Pacote da Primeira Hora

☐ Coleta de lactato Hora ___: ___
☐ Coleta de hemoculturas (antes do antibiótico) Hora:___: ___
☐ Coleta de culturas de outros possíveis focos (antes do antibiótico) Material: _____ Hora:___: ___
☐ Iniciar antibiótico EV em até 1 hora Hora: ___: ___
☐ Reposição volêmica (30 mL/kg se hipotensão ou lactato ≥ 4) Hora: ___: ___
☐ Iniciar vasopressor se PAM < 65 após volume Hora: ___: ___
☐ Monitorar débito urinário (DU ml/kg/hr)

Pacote das seis horas e fechamento do protocolo de sepse		
☐ Reavaliar reposição de líquidos 30 mL/kg (se hipotensão ou lactato ≥ 4mmo/L persistente) ☐ Vasopressor se PAM < 65 mmHg após volume e qual:_____ (Meta PAM ≥ 65 mmHg) ☐ Reavaliação da perfusão tecidual (Tempo de preenchimento capilar, PVC, debito urinário, $ScvO_2$) ☐ Lactato sérico de controle (Redução ≥ 10–20% em relação ao valor inicial) ☐ Controle de foco infeccioso, qual_____.		
Classificação	**Destino do paciente**	**Médico Responsável**
☐ Descartada infecção- suspender antibiótico ☐ Sepse ☐ Choque séptico ☐ Infecção sem sepse	☐ Transferência para UTI ☐ Transferência para Enfermaria ☐ Transferência para outra instituição ☐ Óbito	_____ Assinatura e Carimbo

Anexo 3. Instrumento de auditoria clinica protocolo de sepse

INSTRUMENTO DE AUDITORIA CLÍNICA PROTOCOLO DE SEPSE

Data da auditoria: ____/____/____
Data da admissão: ____/____/____ Admissão UTI: ____/____/____
Permanência UTI ____ dias
Data alta: ____/____/____
Nome do paciente:
Nome da mãe:
Prontuário:

( ) Sepse ( ) Choque Séptico ( ) Infecção por Sepse ( ) Descartado infecção

ITENS DE AVALIAÇÃO					
	S	**N**	**NA**	**Observação**	**Fonte**
Setor em que o protocolo foi aberto?					Salux
Qual profissional abriu o protocolo?					Salux
Paciente clínico?					Salux
Paciente cirúrgico?					Salux
Avaliação médica realizada em até 10 minutos após abertura do protocolo?					Salux
Resultado do lactato liberado pelo laboratório em até 45 minutos?					
Antibiótico administrado em até uma hora?					Salux
Antibiótico prescrito adequado para o foco?					Salux
Realizado coleta das hemoculturas antes da administração do antibiótico?					Salux
Presença de disfunção orgânica?					Salux
Iniciado vasopressores?					Salux
Realizado ressuscitação volêmica adequada (30ml/kg de solução cristaloide)?					Salux
Coletado segunda amostra de lactato após reposição volêmica?					Salux
Fechamento do protocolo adequado?					Salux
Óbito associado a sepse?					Salux

Observações complementares:

_____

_____

_____

Auditor Responsável: _____.

8. REFERÊNCIAS

- SINGER, M.; DE SANTIS, E.; LEDOUX, D.; MARINOLO, C.; et al. *The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3)*. JAMA – Journal of the American Medical Association, v. 315, n. 8, p. 801-810, 23 fev. 2016. DOI: 10.1001/jama.2016.0287. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26903338/. Acesso em: 23 dez. 2025.

- EVANS, L.; RHODES, A.; ALHAZZANI, W.; ANTONELLI, M.; COOPERSMITH, C. M.; FRENCH, C.; et al. *Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock 2021*. Critical Care Medicine, v. 49, n. 11, p. e1063-e1143, 2021. DOI: 10.1097/CCM.0000000000005337. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34599691/. Acesso em: 23 dez. 2025.

- OLIVEIRA, Ana Paula Amestoy de; URBANETTO, Janete de Souza; CAREGNATO, Rita Catalina Aquino. *National Early Warning Score 2: transcultural adaptation to Brazilian Portuguese*. Revista Gaúcha de Enfermagem, Porto Alegre, v. 41, p. e20190424, 2020. DOI: 10.1590/1983-1447.2020.20190424. Disponível em: https://hdl.handle.net/10923/19034. Acesso em: 23 dez. 2025.

- INSTITUTO LATINO AMERICANO DE SEPSE. *Guia prático de terapia antimicrobiana na sepse* [livro eletrônico]. 3. ed. São Paulo: Instituto Latino Americano de Sepse, 2024. PDF. ISBN 978-65-992258-3-3.

9. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
001	30/12/2025	Versão Inicial

Elaboração: Aline Stephanie Pérez Gómez –Médica CCIH – FCECON Assinatura: gov.br Documento assinado digitalmente ALINE STEPHANIE PEREZ GOMEZ Data: 05/01/2026 13:44:33-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	Data: 30/12/2025
Aprovação: Hilka Flavia do Espirito Santo – DITEC Assinatura: HILKA FLAVIA BARRA DO ESPIRITO SANTO ALVES PEREIRA:31006337253 Assinado de forma digital por HILKA FLAVIA BARRA DO ESPIRITO SANTO ALVES PEREIRA:31006337253	Data: 30/12/2025